# Épilepsie en établissement : organisation

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

Protocoles individuels, midazolam buccal par des non-soignants, nuit et SUDEP, calendrier des crises, neurologue.
MAS · FAM · EAM · IME · IEM (EHPAD si concerné) — médecin d'établissement, IDE, équipes éducatives

**À RETENIR**

**Chaque personne épileptique a un protocole individuel validé par son neurologue, connu de jour comme de nuit. Benzodiazépine seulement si convulsions > 5 min ou crises répétées sans retour à une conscience normale ; jamais en phase post-critique.**

*Sources : HAS, Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes, RBP (validée 08/10/2020), R58-R60*

## PROTOCOLE INDIVIDUEL

- Validé par le **neurologue ou neuropédiatre** (risque d'état de mal, salves, syndrome spécifique).
- Contenu : crises habituelles décrites, durée habituelle, **critère objectif** de traitement (durée chronométrée), médicament et dose, quand appeler le 15 → **« Fiche d'urgence individuelle (PAI) »**.
- Équipes informées de ce qui est « crise certaine », « crise probable » ou « manifestation comportementale » (grilles d'observation, fiches de crise).
- Révision à chaque changement de traitement et au moins chaque année (proposition DOTR).

*Sources : HAS 2020, R60, R138, R139 · Eduscol fiche PAI n° 4 (2023) · proposition DOTR*

## MIDAZOLAM BUCCAL PAR UN NON-SOIGNANT

- **Cadre** : aide à la prise = acte de la vie courante si le mode de prise ne présente « ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier », sur prescription et protocole élaboré avec l'équipe soignante.
- **ARS/OMéDIT IDF (01/2025)** : Buccolam et adrénaline auto-injectable relèvent de l'aide aux actes de la vie courante (présentation prédosée) ; formation recommandée.
- **Limites** : position régionale, sans valeur nationale ; un « si besoin » qui suppose d'apprécier l'état clinique n'est pas un acte de la vie courante (TA Dijon, 25/01/2024) → critère **objectif** écrit.
- **Une seule dose** ; seringue vide remise aux secours. Diazépam intrarectal : IDE (choix DOTR).

*Sources : CASF L313-26 · OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM en ESMS handicap, v1 (01/2025) · TA Dijon n° 2000998 (cité par FNASFO, 03/2026) · EMA, RCP Buccolam*

## LA NUIT ET LA MORT SUBITE (SUDEP)

- SUDEP : environ **1/1 000 adultes** et **1/4 500 enfants** épileptiques par an. Principal facteur de risque : **crises tonico-cloniques généralisées (CTCG)**, d'autant plus qu'elles sont fréquentes.
- Information en entretien face à face, sans dramatiser, pour les patients à risque (HAS R31). Le contrôle des crises, surtout des CTCG, réduit le risque.
- CTCG fréquentes et nocturnes : surveillance nocturne ou écoute à distance chez des patients sélectionnés (AAN, niveau C).
- **Détecteurs portables** cliniquement validés : recommandés (faiblement) pour les CTCG, surtout chez une personne non surveillée, si l'alarme permet d'intervenir **en moins de 5 min** ; non recommandés pour les autres crises. Indication : neurologue.

*Sources : AAN/AES, Harden et al., Neurology 2017;88:1674-80 · ILAE-IFCN, Beniczky et al., Epilepsia 2021 (doi 10.1111/epi.16818) · HAS 2020, R31*

## RECUEIL DES CRISES ET LIEN NEUROLOGUE

- **Calendrier des crises** : date, heure, durée, type, circonstances (sommeil, fièvre, oubli de prise), traitement d'urgence, récupération.
- **Filmer** une manifestation nouvelle ou inhabituelle ; vidéo au médecin par **HEALPHI**.
- Avant chaque consultation : calendrier, vidéos, traitements, effets indésirables ; après : protocole individuel mis à jour (proposition DOTR).
- Réévaluer régulièrement les traitements ; neuroleptique choisi selon le risque d'abaissement du seuil ; effets indésirables → **CRPV**.

*Sources : HAS 2020, R106-R108, R137, R140 · proposition DOTR*

## CONDUITE À TENIR (RAPPEL)

- Noter l'**heure de début** ; protéger sans contenir ; rien dans la bouche.
- **15** : convulsions > 5 min, crises répétées sans reprise de conscience, respiration anormale, traumatisme, première crise, **pas d'arrêt 10 min après le Buccolam**.
- Après la crise : PLS, surveillance de la respiration et de la conscience.
- IDE : protocole « Crise convulsive prolongée – Midazolam buccal » ; voies IM / IV sur prescription (outil chariot d'urgence DOTR).

*Sources : HAS 2020, R57-R59 · RFE SRLF/SFMU, états de mal épileptiques (2018) · EMA, RCP Buccolam · Fiche 0 DOTR*

## FORMATION ET CONTRÔLE DE LA DOTATION

- Personnes appelées à administrer : reconnaître la crise, chronométrer, administrer (démonstration), PLS, appeler le 15 ; parcours d'habilitation à l'aide à la prise (ARS IDF).
- Équipe de nuit, remplaçants : liste des personnes à risque et emplacement des traitements à la prise de poste (proposition DOTR).

☐ Buccolam nominatif : présent, non périmé, intact, accessible aux personnes formées ; double pour les sorties — contrôle mensuel (proposition DOTR)

☐ Après usage : remplacement, traçabilité, avis médical, protocole revu

*Sources : OMéDIT IDF/ARS IDF (01/2025) · FAHRES, recherche-action NEXTHEP, items 2.4 et 2.9 (CNSA, 02/2026) · proposition DOTR*

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.